

1. На скільки відсотків маса тіла перевищує фізіологічну норму в пацієнта з II-м ступенем ожиріння?

+ a.70-80%

b.20-25%

c.10-15%

d.30-49%

e.50-60%

2. Яку модель ходьби доцільно використовувати для літніх пацієнтів на ранніх етапах реабілітації після оперативного втручання у зв'язку з ендопротезуванням кульшового суглоба?

a.Триточкову модель ходьби з милицями

+ b. Модель ходьби з ходунками

c.Чотириточкову модель ходьби з милицями

d.Двоточкову модель ходьби з милицями

e.Модель ходьби з ролатором

3. Для оцінювання якого критерію використовується оригінальна проба Ромберга як частина неврологічного обстеження серед здорових чоловіків і жінок?

a. Когнітивних порушень

b.Динамічної рівноваги

c.Постави

+ d.Ризику падіння

e.Відчуття локалізації

4. Пацієнтка віком 42 роки звернулася до фізичного терапевта з проханням призначити візок. Із анамнезу відомо, що пацієнтка 3 роки тому травмувала хребет на рівні L2-L3 під час автодорожньої пригоди. Об'єктивно спостерігається: зріст пацієнтки - 165 см, маса тіла - 68 кг, міжвертельний розмір - 63 см, довжина верхньої кінцівки - 65 см, довжина нижньої кінцівки від підлоги до лобкового симфізу - 87 см, довжина до вертлюга стегнової кістки - 91 см, довжина стегна до краю сідниці - 40 см, довжина гомілки - 30 см. Надайте рекомендації для виготовлення довжини сидіння візка.

a.38 см

b.30 см

c.45 см

+ d.42 см

e.40 см

5. Які шкали можна використати у пацієнта з ХОЗЛ для оцінювання тяжкості задишки?

+ a.Шкала Борга, Візуальна аналогова шкала, Модифікована шкала Медичної дослідницької ради

b.Шкала Берга, Візуальна аналогова шкала, Шкала Score

c.Шкала Борга, Анкета клініки св. Георгія, Модифікована шкала Ренкін

d.Шкала Борга, Шкала Score, Анкета клініки св. Георгія

e.Шкала Борга, Візуальна аналогова шкала, Шкала Score

6.Який із нижченаведених клінічних тестів використовується для вимірювання рівноваги шляхом оцінювання ризиків падіння у пацієнтів із захворюваннями чи травмами центральної нервової системи?

- a.Шкала Борга
- + b.Шкала Берга
- c.Індекс Рівермід
- d.Шкала Ренкін
- e.Індекс Бартела

7.На скільки сантиметрів змінюється відстань між остистими відростками під час проведення проби Отта в нормі?

- + a.Збільшується на 3-4 см
- b.Зменшується на 1 см
- c.Збільшується на 0,5 см
- d.Зменшується на 12 см
- e.Збільшується на 8-9 см

8.Якими основними методами визначаються показники зовнішнього дихання?

- a.Пневмографією, статографією
- + b.Спірометрією, спірографією
- c.Спірографією, пікфлоуметрією
- d.Спірометрією, пневмографією
- e.Статографією, пікфлоуметрією

9. До якого виду вправ належить "напівприсід на балансувальній платформі"?

a. Для розвитку динамічної рівноваги

+ b. Для розвитку статичної рівноваги

c. На гнучкість

d. На витривалість

e. Для розслаблення

10. Який тест є важливим елементом під час підготовки до реабілітації, тому що дає можливість визначити готовність пацієнта до початку фізичних навантажень?

a. Тест балансу Берга

b. Чотириетапний тест балансу

c. Функціональний тест м'язів стегна

+ d. Тест 2-хвилинної ходьби

e. Тест 4-х квадратів

11. Спортсмен після загострення остеоартрозу колінного суглоба отримав рекомендації фізичного терапевта щодо розвитку кардіореспіраторної витривалості. Фізичний терапевт рекомендував тренування за допомогою аеробних вправ від 20 до 30 хв зі збільшенням інтенсивності до діапазону 60-85% максимального ЧСС. На якій стадії розвитку кардіореспіраторної витривалості перебуває спортсмен?

a. Початковій

+ b. Вдосконалення

c. Впрацювання

d. Відновлення

e. Підтримання

12. Як впливають помірні та невеликі фізичні навантаження на функцію нирок та сечового міхура пацієнтів?

a. Стимулюють тонус, поліпшують регенерацію

b. Знижують добове сечовиділення

+ c. Стимулюють сечовиділення

d. Пригнічують сечовиділення

e. Регулюють нервово-психічні процеси

13. У п'ятирічного хлопчика зі збереженими розумовими здібностями ДЦП проявляється нерегулярними спонтанними швидкими змінами - скорочення-розслаблення м'язів рук і ніг, мимічних м'язів обличчя на тлі загального зниженого м'язового тону. Коли дитина хвилюється, рухи рук і голови посилюються. У хлопчика також є порушення артикуляції і темпу мовлення. Про яку форму ДЦП свідчать такі клінічні показники?

a. Спастичну геміплегію

+ b. Гіперкінетичну

c. Змішану

d. Атонічно-астатичну форму Ферстера

e. Спастичну диплегію

14. Що рекомендовано для профілактики контрактур нижніх кінцівок?

a.Вправи для розвитку сили

b.Правильне розтягування та розігрівання м'язів перед вправами

c.Інтенсивні вправи для розвитку витривалості

+ d.Позиціювання в ліжку сидіння, регулярне стояння та/або ходьба

e.Використання природних засобів: лікувальні ванни, креми та мазі

15.Чоловік віком 41 рік скаржиться на труднощі під час спускання сходами вниз. За результатами обстеження виявлено: ММТ розгиначів гомілки - 4 бали, інших м'язів нижньої кінцівки - 5 балів. Пацієнту рекомендовано: вправи на степ-платформі. На який м'яз скерована фізична терапія в цьому разі?

+ a.Чотириголовий

b.Прямий м'яз стегна

c.Напівперетинчастий

d.Латеральну широку фасцію стегна

e.Двоголовий м'яз стегна

16.Для яких тренувань у рамках програми кардіореабілітації характерні: періодичні та короткі серії навантаження зі 100% цільовою інтенсивністю, удвічі довші відновні періоди з дуже низьким навантаженням або без нього?

+ a.На велоергометрі з інтервальним навантаженням

b.На велоергометрі з помірним навантаженням

c.На велоергометрі з рівномірним навантаженням

d.На велоергометрі зі ступінчасто-зростаючим навантаженням

e.На велоергометрі з параболічним навантаженням

17.Укажіть оптимальне антиконтрактурне положення у разі опіку стегна.

- a. Нейтральне положення під кутом відведення 45°
- b. -
- + c. Нейтральне положення під кутом відведення 20°
- d. Нейтральне положення під кутом відведення 30°
- e. Нейтральне положення під кутом відведення 60°

18. Після артроскопії у пацієнта виявлено обмеження згинання гомілки ($0-32^{\circ}$). Яким має бути мінімально необхідний кут згинання в колінному суглобі для забезпечення нормальної біомеханіки ходьби?

- + a. 60°
- b. 45°
- c. 50°
- d. 40°
- e. 35°

19. Під час тестування у вихідному положенні пацієнта лежачи на спині фізичний терапевт зігнув ліву нижню кінцівку пацієнта у кульшовому суглобі під кутом 45° і в колінному суглобі під кутом 90° . Присівши на ступню лівої нижньої кінцівки, фізичний терапевт захопив ліву гомілку пацієнта за верхню третину, потягнув на себе і встановив зміщення гомілки вперед у колінному суглобі на 7 мм. Яка структура, найімовірніше, пошкоджена у пацієнта в цьому разі?

- + a. Передня хрестоподібна зв'язка
- b. Медіальна колатеральна зв'язка
- c. Медіальний меніск
- d. Латеральний меніск
- e. Задня хрестоподібна зв'язка

20. Фізичний терапевт оцінює силу трапецієподібного м'яза. Пацієнт у положенні сидючи самостійно піднімає плечі вгору з максимальною амплітудою, але не може виконати рух, якщо фізичний терапевт чинить невеликий опір руховій дії. Визначте максимальний бал за ММТ.

a.1

b.5

+ c.3

d.4

e.2

21. Який тест можна застосувати, щоб оцінити здатність пацієнта модифікувати ходьбу, пов'язану з рухом голови, когнітивними завданнями, зміною її швидкості чи перешкод?

a.Десятиметровий тест ходьби

b.Шестиметровий тест ходьби

c.Тест Тінетті

d.Шестихвилинний тест ходьби

+ e.Динамічний індекс ходьби

22.Пацієнт віком 43 роки скаржиться на неможливість швидко пересуватися через задишку та нешвидкий темп ходьби (атаксія не виявлена). В анамнезі: ГПМК. Який тест доцільно використати для оцінки функціонального статусу пацієнта?

+ a.6-хвилинна ходьба

b."Ходьба на 10 метрів" з обліком часу

с."Встань та йди" з обліком часу

d.Динамічний індекс ходьби

е."Ходьба на 6 метрів" з обліком часу

23.Кукса характеризується такими показниками: зниженою функцією м'язів, болючістю під час пальпації, нестійкістю об'ємних розмірів, має атрофічні в'ялі тканини, на їх торцевих поверхнях можуть бути трофічні розлади шкіри без запальних явищ. Кукса може призвести до згинальної або розгинальної контрактури суміжного суглоба, помірної вираженої неспроможності зв'язок суглоба, довжина кукси недостатня для керування протезом (коротка кукса). Укажіть цей вид кукси.

a.Нефункціональна

b.Коротка

с.Довга

+ d.Малофункціональна

е.Функціональна

24.Укажіть тип порушення постави, при якому спостерігається гіперлордоз поперекового відділу.

+ a.Кругло-увігнута спина

b.Сколіотична постава

с.Сутула спина

d.Кіфосколиоз

е.Плоска спина

25.До фізичного терапевта звернувся чоловік віком 29 років зі скаргами на біль по задній поверхні лівого стегна. З анамнезу відомо, що біль виник раптово під час гри у футбол, зокрема при різкому прискоренні. Було встановлено пошкодження двоголового м'яза стегна. Який механізм ушкодження м'яза найбільш імовірний у цьому разі?

a.Фацілітація напруженого м'яза

b.Концентричне скорочення

+ c.Ексцентричне скорочення

d.Ізометричне скорочення

е.Ідеомоторна вправа

26.Які ознаки вказують на патологічні (не притаманні для вікових змін) порушення ходьби пацієнта літнього віку?

a.-

+ b.Ретропульсія, асиметричність, вкорочення кроку, циркумдукція, пришвидшення, нахил тулуба

c.Зміна відмашки рук, асиметричність, видовження кроку, циркумдукція, пришвидшення, нахил тулуба

d.Зміна відмашки рук, симетричність, вкорочення кроку, циркумдукція, пришвидшення, нахил тулуба

е.Ретропульсія, симетричність, вкорочення кроку, циркумдукція, пришвидшення, нахил тулуба

27.За якою шкалою проводиться оцінка індивідуального сприйняття навантаження?

a.Берса

b.Бреса

+ c.Борга

d.Брюса

е.Берга

28.Пацієнт віком 40 років два роки тому потрапив у ДТП та отримав травму спинного мозку. Після цього у чоловіка розвинувся спастичний парепарез нижніх кінцівок. Неврологічний рівень ураження - T8. Сила м'язів нижче рівня ураження не перевищує 1-2 бали. Присутнє крижове збереження. Визначте тяжкість пошкодження за шкалою ASIA)

a.D

+ b.C

c.E

d.B

е.А

29.Чоловіка віком 32 роки шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з діагнозом: гостре порушення мозкового кровообігу. Пацієнт знаходиться у нестабільному стані. Коли фізичний терапевт має розпочати реабілітаційні заходи з цим пацієнтом?

+ а.Після стабілізації стану пацієнта у відділенні інтенсивної терапії

б.Після переведення пацієнта до палати стаціонару

с.Після виписки пацієнта в реабілітаційний центр або відділення

д.Відразу після шпиталізації

е.У відділенні інтенсивної терапії за 7 днів після шпиталізації

30.Пацієнт віком 75 років має вологий (продуктивний) кашель більше ніж 10 років та задишку, що виникає під час фізичного навантаження. Встановлено діагноз: ХОЗЛ. Яке дихання доцільно застосувати для очищення дихальних шляхів від мокротиння та зменшення задишки?

а.-

+ б.Із позитивним тиском на видиху

с.Із негативним тиском на вдиху

д.Із негативним тиском на видиху

е.Із позитивним тиском на вдиху

31. Які реабілітаційні заходи рекомендовані пацієнтам після стабільно-функціонального остеосинтезу перелому шийки стегнової кістки?

- a. Пасивні рухи в колінному та кульшовому суглобах із 4-го дня після операції
- b. Суворий постільний режим протягом 2-х тижнів
- c. Берегти кульшовий і колінний суглоби, але активно застосовувати рухи здоровою ногою
- d. Створити спокій для кінцівки протягом місяця на ортопедичній шині, але активні рухи в колінному суглобі проводити з 4-го дня після операції
- + e. Терапевтичні вправи з 2-го дня після операції, ходьба на милицях із 5-6-го дня

32. Тримісячній дівчинці встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле попереково-крижового відділу хребта, spina bifida L4-S1. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

- a. Сидіти незалежно, перевертатися, повзати і ходити навчиться вчасно
- b. Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць
- c. Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне
- d. Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість та зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок

+ е.Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO

33.Що є протипоказанням для аеробних тренувань на витривалість для пацієнтів кардіологічного профілю?

а.Гіпертонічна хвороба I ступеня

б.Серцева недостатність II функціонального класу NYHA

+ с.Виражена вторинна мітральна недостатність

д.Зниження життєвої ємності легень до 85% від прогнозованого значення

е.Підвищення систолічного артеріального тиску на 20 мм рт. ст. при фізичному навантаженні

34.Пацієнтка скаржиться на обмеження рухів у ліктьовому суглобі після зняття іммобілізації (2 тижні тому), біль відсутній. Фізичний терапевт після обстеження встановив наявність постіммобілізаційної згинально-розгинальної контрактури ліктьового суглоба. Пасивні фізіологічні рухи яких ступенів амплітуди за Мейтландом, необхідно використовувати для відновлення амплітуди рухів у ліктьовому суглобі?

а.I, II та IV

б.I та IV

+ с.III та IV

д.II та III

е.I та II

35.Дванадцятирічній дівчинці встановлено діагноз: ДЦП. По дому та в школі зазвичай ходить самостійно, але інколи, для більшої безпеки, використовує тростинку.

Сходінками може підійматися тільки тримаючись за перила. Стрибати та бігати не вміє. Визначте рівень рухових порушень за GMFCS.

a.V

b.III

+ c.II

d.I

e.IV

36. Яку тактику необхідно використати для лікування пацієнта з правобічним спастичним геміпарезом зі збереженими селективними рухами пальців і кисті, щоб уникнути "навченого невикористання" верхньої кінцівки?

+ a.Обмеження неушкодженої руки та посилення тренування/використання ураженої руки

b.Вправи на силу та координацію м'язів ураженої кінцівки

c.Розвиток координаторних якостей верхньої кінцівки

d.Посилення тренування/використання ураженої руки

e.Кінезіотерапія, вправи на амплітуду руху

37.Фізичний терапевт відділення інтенсивної терапії розпочинає реабілітацію пацієнта віком 32 роки, що потрапив у ДТП і має травматичні ушкодження хребта. На другий день після травмування йому було проведено обстеження за шкалою ASIA) Результати обстеження рівня чутливості та моторики: T2/T2. Крижове збереження відсутнє. Який рівень за шкалою ASIA (AIS) має цей пацієнт?

- a.C
- b.E
- c.D
- + d.A
- e.B

38.Які зміни дихальних шумів можна виявити в пацієнта з плевральним випотом під час аускультації легень?

- a.Вологі хрипи
- b.Крепітацію
- c.Сухі хрипи
- d.Бронхіальне дихання
- + e.Відсутність дихальних шумів

39.Фізичному терапевту необхідно провести обстеження для визначення ступеня виразності феномена "learned non-use" ("навчився не використовувати") ураженої верхньої кінцівки у пацієнта з центральним парезом. Який тест для цього доцільно використати?

- a.Функціональна незалежність
- b.Мотрісіті
- c.Стратегії руху

d.Оцінка моторики

+ e.Френчай

40.Укажіть тренувальну частоту серцевих скорочень за формулою Карвонена, якщо:
ЧСС у стані спокою становить 60/хв, максимальна ЧСС - 120/хв, цільова інтенсивність
від резервної ЧСС - 60%.

a.72/хв

b.102/хв

c.88/хв

d.100/хв

+ e.96/хв

41.Яку модель ходьби потрібно використовувати на ранніх етапах реабілітації після
оперативного втручання у зв'язку з ендопротезуванням кульшового суглоба?

a.Модель ходьби з ходунками

+ b.Триточкову модель ходьби з милицями

c.Чотириточкову модель ходьби з милицями

d.Двоточкову модель ходьби з милицями

e.Модель ходьби з ролатором

42. До молодого фізичного терапевта звернувся чоловік віком 26 років зі скаргами на ушкодження правого коліна. У процесі опитування фізичний терапевт сформулював 2 ймовірні гіпотези порушення рухливості в колінному суглобі. Одна з них: порушення цілісності передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Який діагностичний тест має більшу чутливість і специфічність, ніж інші, для підтвердження або спростування цієї гіпотези?

a. Еплі

b. Передньої висувної шухляди

c. Задньої висувної шухляди

+ d. Лахмана

e. Мак-Мюррея

43. Під час обстеження полів зору за методикою "Плавного стеження" у пацієнта з наслідками ЗЧМТ (середній ступінь тяжкості) виявлено диплопію (двоїння) при погляді вниз. Ураження якого черепно-мозкового нерва спостерігається в пацієнта?

a. Трійчастого

b. Зорового

с.Окорухового

d.Відвідного

+ е.Блокового

44.Під час обстеження чоловіка після гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) за функціональною шкалою рівноваги Берга пацієнт набрав 39 балів. Про що свідчить така кількість балів?

a.Незалежність від зовнішньої підтримки з малим ризиком падіння

+ b.Здатність ходити з допомогою із середнім ризиком падіння

с.Здатність ходити без допоміжних засобів

d.Повністю залежить від інвалідного візка з високим ризиком падіння

е.Здатність переміщуватись із високим ризиком падіння

45.Військовослужбовець віком 41 рік отримав пошкодження спинного мозку внаслідок мінно-вибухової травми. Під час обстеження м'язової сили за мануально-м'язовим тестом встановлено, що сила м'язів відведення у плечовому суглобі з обох боків становить 5 балів, розгинання у правому зап'ястку - 5 балів, у лівому - 4 бали, розгинання у ліктьовому суглобі з обох боків - 0 балів. Під час оцінки поверхневої чутливості встановлено, що в сегментах C2-T1 чутливість становила 2 бали, у сегменті T2 - праворуч 2 бали, ліворуч - 1 бал, у сегменті T3 - з обох боків 0 балів. Оцініть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку за шкалою AIS.

a.C6

b.T2

с.T1

+ d.C5

е.С7

46. Фізичний терапевт оглядає пацієнтку віком 40 років із дегеративно-дистрофічними змінами. Вона скаржиться на головний біль, біль у лівій частині шиї та лівій верхній кінцівці, скутість у шийному відділі хребта. Пальпаторно відзначається напруження драбинчастих м'язів і верхнього трапецієподібного м'яза. Обмежена амплітуда руху під час контралатерального нахилу голови. Яке ефективне втручання має застосувати фізичний терапевт для швидкого зняття локального гіпертонусу м'язів?

а. Динамічні фізичні вправи для шийного відділу хребта

б. Імобілізацію шийного відділу хребта

с. Витягування шийного відділу хребта

+ д. Постізометричну релаксацію

е. Фізичні вправи на опір

47. Із якою метою застосовують валик під стегна та нижню частину живота, виконуючи позиціонування лежачи на животі?

а. Для усунення лордозу поперекового відділу хребта

б. Для тренування м'язів живота

+ с. Для збільшення черевного тиску

д. Для зменшення черевного тиску

е. Для зменшення напруження м'язів плечового пояса та ротаторів

48. Під час обстеження у пацієнта м'язів задньої поверхні стегна за шкалою Ашфорт при здійсненні швидкого пасивного згинання гомілки відзначається мінімальний опір наприкінці амплітуди руху. На що вказує така симптоматика?

a. Помірне підвищення м'язового тону

b. Значне підвищення м'язового тону

c. Незначне підвищення м'язового тону

d. М'язову ригідність

+ e. Легке підвищення м'язового тону

50. Чоловіку віком 54 роки встановлено діагноз: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, III ФК. Пацієнт проходить постстаціонарну фізичну терапію в кардіологічному санаторії. Йому показані аеробні фізичні навантаження. Яку форму та дозу аеробного навантаження має призначити фізичний терапевт відповідно до функціонального класу на початку проведення санаторного курсу кардіореабілітації?

a. Дозована ходьба в повільному темпі (70-80 кроків/хв) із зупинками через кожні 100-200 м

b. Дозована ходьба в темпі 90-100 кроків/хв з короточасним прискоренням по 2-3 хв у темпі 120-30 кроків/хв

c. Дозована ходьба в помірному темпі (110 кроків/хв) з короточасним прискоренням по 3-5 хв у темпі 120-30 кроків/хв

+ d. Дозована ходьба в середньому темпі (90 кроків/хв)

e. Біг у помірному темпі

51.Пацієнт скаржиться на часті запаморочення, головокружіння під час зміни положення голови. В анамнезі: черепно-мозкова травма. Який тест потрібно провести для вестибулярного обстеження?

- a.Тест стояння на одній нозі
- b.Тест сенсорної організації
- c.Імпульсний тест голови
- + d.Маневр Дікса-Холпайка
- e.Міні-тест оцінки системи динамічної рівноваги

52.Укажіть вихідну позицію для страхування пацієнта після ГПМК з лівостороннім геміпарезом під час спускання сходами.

- a.Попереду та трохи праворуч від пацієнта
- b.Позаду та трохи праворуч від пацієнта
- + c.Попереду та трохи ліворуч від пацієнта
- d.Позаду та трохи ліворуч від пацієнта
- e.Позаду пацієнта

53. Під час проведення мануально-м'язового тестування сили м'язів, які розгинають гомілку, фізичний терапевт встановив, що пацієнт може долати невеликий спротив, при цьому амплітуда руху в колінному суглобі була неповною. Який сегмент спинного мозку, найімовірніше, уражений у цьому разі?

a.L4

+ b.L3

c.L2

d.L5

e.L1

54. Пацієнт після перенесеної ЧМТ перебуває на післягострому етапі реабілітації. За результатами обстежень пацієнта констатовано п'ятий рівень за когнітивною шкалою Ранчо Лос Амігос та 40 балів за індексом Бартел. Який подальший реабілітаційний маршрут пацієнта згідно з отриманими результатами обстеження та критеріями направлення для надання реабілітаційної допомоги?

+ a. Реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах

b. Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах

c. Паліативна допомога в умовах хоспісу

d. Медсестринський догляд у відділенні неврології

e. Телереабілітація в домашніх умовах

55.Який тест можна використовувати для оцінювання координаційних здібностей літніх людей?

a.Флосінга

b.Френчай

c.Ловетта

d.Мотрісіті

+ e.Тіннеті

56.Які фізичні вправи не показані пацієнтам із діагнозом: хронічний гломерулонефрит, підгостра форма?

a.Коригувальні

b.На розтягування

+ c.Силові

d.Дихальні

e.На розслаблення

57.Пацієнту із геміпарезом після перенесеного ішемічного інсульту в ранньому відновному періоді планується провести динамічну електростимуляцію. На яких м'язах потрібно розміщувати електроди під час проведення цієї процедури?

a.На синергістах спастичних м'язів руки та ноги

b.На спастичних м'язах руки та ноги

+ c.На антагоністах спастичних м'язів руки та ноги

d.На антагоністах спастичних м'язів руки та синергістах спастичних м'язів ноги

е.На м'язах агоністах

58.Якою має бути висота ручки 4-опірної палиці як допоміжного засобу пересування для особи із гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК)?

+ а.На висоті згину зап'ястка

б.На висоті ліктя

с.На висоті середини передпліччя

д.На висоті 1/3 передпліччя

е.На висоті кінчиків пальців

59. Новонародженій дитині діагностовано правобічну вроджену м'язову кривошию. На що треба спрямувати заходи фізичної терапії в цьому разі?

а.Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку, стимуляцію трапецієподібного м'яза з лівого боку

б.Розслаблення трапецієподібних м'язів з обох боків та стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з правого боку

+ с.Розслаблення груднинно-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'язів з правого боку, стимуляцію цих м'язів з лівого боку

д.Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібного м'яза з лівого боку та стимуляцію трапецієподібного м'яза з правого боку

е.Стимуляцію груднинно-ключично-соскоподібних м'язів із правого та лівого боків, стимуляцію трапецієподібних м'язів з обох боків

60. Фізичну працездатність пацієнтів, які хворіють на бронхіальну астму, оцінюють шляхом індивідуальної можливості витримувати фізичне навантаження. Який метод застосовують у цьому разі?

- a. Купера
- b. Спірометрії
- c. Спірографії
- d. Стрельникової
- + e. Велоергометрії

61. Яке положення нижньої травмованої кінцівки спостерігатиметься у разі позитивного тесту Обера в пацієнта із синдромом іліотібіального тракту?

- a. Приведення
- + b. Відведення
- c. Розгинання
- d. Внутрішня ротація
- e. Згинання

62. Який тест із нижченаведених оцінює індекс ураження щодо різних видів діяльності та призначений для оцінки рухової функції, рівноваги, чутливості й функціонування суглобів у пацієнтів із постінсультною геміплегією?

+ а. Фугл-Мейєра

б. Із дев'ятьма лунками та кілочками

с. Френчай

д. Берга

е. Викреслювання ліній

63. Для збільшення амплітуди рухів при артрогенній контрактурі колінного суглоба у пацієнта вирішили використовувати мобілізацію за методом Кальтенборна третього ступеня. Якою буде середня тривалість обраної мобілізації?

а. 40-50 с

б. 10-15 с

с. 50-60 с

+ д. 30-40 с

е. 20-30 с

64. Укажіть тип вправ, що найбільш ефективний у роботі з пацієнтом, який має мозочкову атаксію.

а. З опором

б. На витривалість

+ с. На покращення балансу

д. З обтяженнями

е.На розтягування

65.Одним із методів оперативного контролю фізичної терапії у довготривалому періоді реабілітації в пацієнтів з COVID-19 та реконвалесцентів є показник сатурації. Укажіть абсолютний мінімум рівня сатурації, у разі якого припиняються терапевтичні вправи.

а.У спокої 90%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум - 80%

б.-

с.У спокої 95%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум - 80%

+ д.У спокої 90%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум - 85%

е.У спокої 95%, під час фізичних навантажень абсолютний мінімум - 85%

66.Пацієнтка віком 45 років, майстер-перукар, звернулася до фізичного терапевта зі скаргами на біль у лівому плечовому суглобі, що збільшується при рухах у суглобі, у нічний час та під кінець робочої зміни. Вимушена обмежувати хатню та професійну роботу у зв'язку зі складністю при згинанні та утриманні руки. Не може розчісуватися та сушити волосся феном, обмежена можливість застібнути бретельки бюстгальтера. Проживає у власному будинку із трирічною донькою. Які скарги характеризують порушення функції?

+ а.Труднощі при згинанні руки

б.Проблеми, пов'язані з проживанням у власному будинку із трирічною донькою

с.Неможливість застібнути бретельки бюстгальтера

д.Обмеження при виконанні хатньої роботи як хозяйки оселі

е.Неможливість сушити волосся феном

67. Які патологічні процеси є причиною зміни альвеолярної вентиляції у пацієнта з обструктивним бронхітом?

a. -

+ b. Бронхоспазм, набряк слизової бронхів, гіперсекреція бронхів

c. Бронхоспазм, набряк легень, гіперсекреція бронхів

d. Набряк слизової бронхів, наявність запального мокротиння у бронхах

e. Бронхоспазм, наявність запального мокротиння у бронхах

68. Чоловік під час ходьби сильно згинає ногу в колінному суглобі, переносючи її вперед, спершу стає на пальці, потім спирається на латеральний край підошви та опускає п'яту. Об'єктивно спостерігається: звисання стопи у позиції підошовного згинання з незначною ротацією до середини, парастезії та казуалгії, знижені ахіловий і підошовний рефлекс, ММТ м'язів дорсальних згиначів стопи - 2 бали, пропріорецептивна чутливість - змінена. Який патологічний процес спостерігається у пацієнта?

+ a. Невропатія маломілкового нерва

b. Плоскостопість

c. Розрив ахілового сухожилля

d. Поліартрит

e. Гонартроз колінного суглоба

69.Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з глибокими опіками ділянки ліктьового суглоба. Протипоказів до обстеження амплітуди рухів немає. Протягом якого терміну треба провести обстеження амплітуди рухів ліктьового суглоба?

a.48 годин з моменту отримання травми

b.24 годин з моменту шпиталізації

c.36 годин з моменту шпиталізації

+ d.72 годин з моменту отримання травми

e.24 годин з моменту отримання травми

70.Укажіть рівень ураження спинного мозку, на якому пацієнти з хребетно-спинномозковою травмою потребуватимуть використання ортезів UFO для забезпечення функції ходьби.

a.L2-L3

b.S2-S4

c.L1-L2

+ d.L4-S1

e.L5-S2

71.У військовослужбовця з легкою ЧМТ спостерігається порушення під час одночасного виконання двох дій. Які завдання має рекомендувати фізичний терапевт у цьому разі?

a.На виконання великої кількості повторень

b.На швидкість виконання

+ c.У дедалі складніших умовах

d.Поділені на підзавдання, для кращого усвідомлення виконання

e.Силового навантаження

72.Із яких вправ може складатися активна корекція хребта пацієнта з діагнозом: правосторонній грудний сколіоз?

a.Нахил вперед із відведенням прямої руки

b.Підйом руки вгору зі сторони випуклості дуги викривлення та нахил ліворуч

c.Нахил назад із ротацією в бік дуги викривлення

+ d.Підйом руки вгору зі сторони увігнутості дуги викривлення та нахил праворуч

e.Відведення руки вбік до горизонталі з боку увігнутості дуги викривлення

73.Пацієнт знаходиться на кардіореабілітації після перенесеного інфаркту міокарда. Які вправи є важливим компонентом фази початкового відновлення для постінфарктних пацієнтів?

a.Вправи постізометричної релаксації для шийного відділу хребта

b.Вправи постізометричної релаксації для грудного відділу хребта

c.Вправи постізометричної релаксації для верхніх та нижніх кінцівок

+ d.3 амплітудою руху для верхніх кінцівок

e.3 амплітудою руху для нижніх кінцівок

74.Після перенесеного COVID-19 у пацієнта спостерігається дуже низька толерантність до навантаження. Яка фізична активність рекомендована цьому пацієнтові у перші 6 тижнів після виписки?

a.Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності двічі на добу

b.Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи середньої інтенсивності

+ c.Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької та середньої інтенсивності з короткими інтервалами

d.Зменшити свою повсякденну діяльність і виконувати фізичні вправи низької інтенсивності

e.Виконувати свою повсякденну діяльність і додаткові фізичні вправи низької інтенсивності тричі на добу

75.Для ліквідації або зменшення яких контрактур треба використовувати постізометричну релаксацію (ПІР)?

a.Капсулярних

b.Артрогенних

c.Міогенних

d.Дерматогенних

e.Десмогенних

76. Жінка віком 75 років 2 тижні перебуває на витяжці у зв'язку з діафізарним переломом лівого стегна. Їй рекомендована фізична терапія. Яка мета фізичної терапії для цієї пацієнтки?

a. Збільшення щільності кісткової маси та покращення функціональної здатності м'язів

b. Відновлення силових показників м'язів нижніх кінцівок

+ c. Профілактика пролежнів і респіраторних порушень

d. Зниження ризику утворення тромбів у ділянці пошкодження

e. Відновлення амплітуди руху в колінному суглобі

77. Фізичний терапевт, працюючи в умовах мультидисциплінарної команди, повинен знати й орієнтуватися, над чим працюють усі члени команди. Які цілі терапевтичних втручань нейропсихолога в роботі з когнітивно-комунікативними наслідками після перенесеної пацієнтом ЧМТ?

a. Проведення спеціальних тестувань на визначення рухового дефіциту мимовільних рухів дрібної моторики

b. Стимуляція нейропластичності

c. Фізичне тренування мобільності та гнучкості

d. Психологічна підтримка та супровід під час занять поза межами приміщень

+ e. Посилення індивідуальної здатності обробляти та інтерпретувати інформацію

78. Який тест використовується для визначення цілісності вестибулярно-очного рефлексу в пацієнтів з черепно-мозковою травмою?

- + a. Імпульсного руху голови
- b. "Чотирьох квадратів"
- c. На ністагм при струшуванні голови
- d. На коефіцієнт чутливості до руху
- e. На динамічну гостроту зору

79. Укажіть структури дихальної системи, порушення прохідності газів крізь які спричиняє симптоми дихальної недостатності в пацієнтів із бронхіальною астмою.

- a. Бронхи 2-4 порядку
- b. Бронхи 4-6 порядку
- + c. Бронхіоли
- d. Альвеолярні мішечки
- e. Альвеолярні ходи

80. Для пацієнтів після інфаркту міокарда існують 3-, 4-, 5-тижневі програми реабілітації. Який показник є визначальним під час вибору кожної з програм?

+ а.Клас тяжкості

b.Рухова активність

c.Індивідуальний підхід

d.Функціональний клас

e.Стан перед загостренням

81.Фізичний терапевт, провівши тестування згиначів передпліччя ізометричним напруженням м'язів, виявив слабке та безболісне напруження. Про яке ймовірне ушкодження свідчить такий результат тестування?

a.Розтягнення м'яза 1-2 ступеня, тендиніт

b.Розтягнення зв'язок 1-2 ступеня

+c.Давні розриви м'яза (загоєний розтяг 3 ступеня)

d.Ентезопатія

e.Міозит

82.Для визначення ступеня сили у пацієнтів із патологічними проблемами широко застосовується ММТ. Що з нижченаведеного правильно визначає спосіб проведення мануального м'язового тестування чотириголового м'яза стегна на оцінку 4?

a.Лежачи, нога зігнута під кутом 90° . Пацієнт розгинає коліно на повну амплітуду проти помірного опору

b.-

с.Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90° , контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт піднімає стегно на повну амплітуду проти помірного опору

d.Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90° , контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт згинає ногу в коліні на повну амплітуду проти помірного опору

+ e.Сидячи на столі, гомілка звисає, коліно зігнуте на 90° , контралатеральне стегно відведене і стопа знаходиться на стільці. Пацієнт розгинає коліно на повну амплітуду проти помірного опору

83.Скільки резерву частоти серцевих скорочень використовують вправи середньої інтенсивності?

a.Від 60% до 80%

b.Від 20% до 40%

с.Від 40% до 80%

+ d.Від 40% до 60%

e.Від 20% до 60%

84.Фізичний терапевт проводить 6-хвилинний тест ходьби чоловіку з порушенням діяльності ССС. Під час тестування пацієнт зупинився та сів на стілець для відпочинку. Які подальші дії фізичного терапевта?

+ a.Тест закінчується, фіксується час та підраховується пройдена відстань

b.Відлік часу зупиняється, у протоколі фіксується час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування

c.Відлік часу не зупиняється, фізичний терапевт пропонує продовжити тестування за допомогою допоміжного засобу, у протоколі фіксується час відпочинку

d.Відлік часу зупиняється, фізичний терапевт оцінює життєво важливі показники, у протоколі фіксуються час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування

e.Відлік часу не зупиняється, у протоколі фіксується час відпочинку, після відпочинку пацієнт продовжує тестування

85.Який критерій є кращим для прогнозування потенціалу навчальної спроможності пацієнтів із черепно-мозковою травмою?

a.Тривалість надання реабілітаційних заходів

b.Тривалість перебування пацієнта в комі

c.Тривалість втрати свідомості пацієнта після отримання травми

d.Тривалість афазії

+ e.Тривалість після травматичної амнезії

86.Пацієнт скаржиться на сильний біль у лівій гомілці та стопі під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри стопи. Лівою ногою пацієнт не може стояти на пальцях, зникла чутливість на задній поверхні гомілки та підшві. Який нерв, найімовірніше, уражений у пацієнта?

a.Великогомілковий

b.Затульний

с.Стегновий

d.Сідничний

е.Малогомілковий

87.Фізичний терапевт проводить у пацієнта оцінювання якості життя за опитувальником Роланла-Морріса. Для оцінки яких станів застосовується цей опитувальник?

a.Хронічного болю в спині

b.Хронічного болю в суглобі

+ c.Гострого та підгострого болю в спині

d.Післятравматичного головного болю

е.Гострого та підгострого болю в суглобі

88.З якого боку має знаходитися фізичний терапевт, щоб страхувати пацієнта із правостороннім геміпарезом під час підйому східцями?

+ a.Праворуч від пацієнта, стоячи на сходинку нижче від нього

b.Ліворуч від пацієнта, стоячи на сходинку нижче від нього

c.Ліворуч від пацієнта, стоячи на сходинку вище від нього

d.Праворуч від пацієнта, стоячи перед ним

е.Праворуч від пацієнта, стоячи на сходинку вище від нього

89.Пацієнтці віком 58 років із симптомами менопаузи та зниженою щільністю кісткової тканини (за результатами рентгенівської денситометрії) з метою нормалізації балансу кальцію та фосфору призначено сеанси ультрафіолетового опромінення діапазону В у суберитемній дозі. Який процес в організмі стимулюватиме цей фізіотерапевтичний метод?

а.Синтез вітаміну D₂ у шкірі

б.Всмоктування вітаміну D₃ в кишечнику

с.Всмоктування вітаміну D₂ в кишечнику

д.Метаболізм вітаміну D в печінці

+ е.Синтез вітаміну D₃ у шкірі

90.Фізичний терапевт звернув увагу на те, що пацієнт під час ходьби оберігає ногу та спирається на неї обережно. За результатами обстеження встановлено: рівень болю за шкалою ВАШ - 5 балів, тонус м'язів у нормі, причиною обмеження пасивної та активної амплітуди рухів є біль, усі види чутливості збережені, нижні кінцівки - антропометрично-симетричні. Який вид патологічної ходьби спостерігається в цього пацієнта?

а.Справжня кульгавість

б.Паралітична ходьба

с.Качина ходьба

+ d.Несправжня кульгавість

e.Спастична ходьба

91.Пацієнтові віком 32 роки з передньо-нижнім вивихом плечової кістки після знеболення проведено вправлення вивиху. Яку фіксацію доцільно виконати пацієнту?

a.Скелетне витягнення за плечову кістку

b.Гіпсову лонгету від травмованого до променево-зап'ясткового суглоба

c.Фіксацію косинкою

+d.Пов'язку Дезо

e.Торако-брахіальну гіпсову пов'язку

92.Який засіб фізичної реабілітації для профілактики контрактур потрібно вибрати при опіковій травмі з перших днів перебування пацієнта в лікарні?

+ a.Позиціонування

b.Терапевтичні вправи

c.Дихальні вправи

d.Масаж

e.Постізометрична релаксація

93. Чоловік із діагнозом: ішемічна хвороба серця - регулярно виконував аеробні тренування на велоергометрі. Кілька днів тому самостійно припинив приймати призначені йому β -адреноблокатори. Яка у цьому разі можлива реакція серцево-судинної системи пацієнта під час виконання тренувань?

- a. Зниження артеріального тиску та зменшення частоти серцевих скорочень
- b. Зменшення частоти серцевих скорочень при незмінному артеріальному тиску
- c. Зниження артеріального тиску та підвищення частоти серцевих скорочень
- d. Підвищення артеріального тиску та зменшення частоти серцевих скорочень
- + e. Підвищення артеріального тиску та підвищення частоти серцевих скорочень

94. На які тканинні структури діє найпоширеніший прийом масажу - погладжування?

- a. Сухожилля
- b. Суглоб, фасції
- c. М'язовий шар
- d. Підшкірна основа
- + e. Епідерміс, власне шкіра (дерма)

95. У чоловіка віком 52 роки на 6-й день після тотального ендопротезування правого кульшового суглоба стан задовільний, ускладнень не виявлено, ранню фізичну терапію розпочато в 1-й день після операції. Яка вправа допоможе розширити руховий режим пацієнта на 8-й день у разі такого перебігу післяопераційного періоду?

a. Тренування переходу з положення сидячи у положення стоячи

b. Тренування ходьби з підлокітною милицею

+ c. Тренування ходьби східцями із милицями

d. Тренування стояння з підлокітною милицею

e. Тренування ходьби східцями без милиць

96. Укажіть ускладнення, що часто виникають у пацієнтів, які перебувають у лежачому положенні понад три тижні.

a. Біль у суглобах, остеопороз, судоми, непрохідність кишечника

+ b. Пневмонії, пролежні, тромбоемболії, зниження сили м'язів

c. -

d. Біль у суглобах, спазмування шлунка, ателектази, контрактури

e. Остеопороз, судоми, пролежні, зниження сили м'язів

97.Пацієнт із бронхопневмонією скаржиться на виснажливий кашель із виділенням невеликої кількості густого мокротиння. За даними рентгенологічного обстеження патологічний осередок локалізований у передньому апікальному сегменті верхньої долі правої легені. Яке вихідне положення найбільш ефективне для проведення постурального дренажу в цього пацієнта?

- + а.Сидячи, з невеликим відхиленням тулуба назад
- б.Сидячи, з невеликим нахилом тулуба вперед
- с.Лежачи на лівому боці, з піднятим тулубом щодо голови
- д.Лежачи на животі, з невеликим підняттям тулуба
- е.Лежачи на правому боці, з піднятим тулубом щодо голови

98.Під час обстеження пацієнта виявлено: повне зникнення активного руху в правій кінцівці, атонія, спастичні явища відсутні, трофіка значно порушена. Який неврологічний синдром, найімовірніше, виник у пацієнта?

- а.Центрального мотонейрона
- + б.Периферичного мотонейрона
- с.Палеоцеребелярний
- д.Паркінсона
- е.Гіпокінетично-ригідний

99. Під час проведення нервово-м'язового обстеження пацієнт знаходився у положенні лежачи на спині, фізичний терапевт підняв нижню кінцівку пацієнта, розігнуту в колінному суглобі, при цьому пацієнт відчув появу болю внизу спини під час згинання ноги в кульшовому суглобі під кутом 82° . Який патологічний стан, найімовірніше, виявлено в пацієнта?

+ а. Пошкодження крижово-клубового суглоба

b. Синдром грушоподібного м'яза

c. Неврит сідничного нерва

d. Поперекова радикулопатія

e. Варіант норми

100. Укажіть найбільш важливий аспект під час здійснення практичної діяльності мультидисциплінарної команди (МДК) та один із основних компонентів мультидисциплінарного підходу.

+ а. Спільна постановка командних цілей реабілітації

b. Залучення до постановки цілей пацієнта чи опікунів

c. Формулювання клініко-реабілітаційного діагнозу

d. Створення реабілітаційного плану

e. Дотримання принципів деонтології

101. У ранній післяшоківий період у пацієнта камбустіологічного профілю до реабілітаційних втручань включають позиціювання, що передбачає викладання пацієнта у фізіологічно правильне положення. Яка мета цього втручання?

a.Перешкоджає вивиху плечового суглоба

b.Покращення кровообігу

c.Знижує ризик запалення

d.Перешкоджає утворенню пролежнів

+ e.Перешкоджає утворенню контрактур

102.Пацієнт віком 50 років зі спастичним колітом в анамнезі, професійна діяльність якого пов'язана з сидячим характером праці, скаржиться на періодично виникаючі переймоподібні болі в животі, хронічний закреп, головний біль, дратівливість. Яке оптимальне вихідне положення має бути при підборі терапевтичних вправ з метою усунення спастичних явищ?

a.Стоячи на колінах

b.Лежачи на животі

c.Лежачи на спині

+ d.Колінно-кистьове положення

e.Лежачі на боці

103.Укажіть оптимальний термін для досягнення однієї короткотривалої функціональної цілі під час реабілітації пацієнта в стаціонарі.

a.7-10 днів

+b.5-7 днів

c.12-14 днів

d.10-12 днів

e.14-21 день

104.Коли можна застосовувати фізичні вправи пацієнтам із діагнозом: виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки?

a.За 30 хв після прийому їжі

b.Незалежно від часу прийому їжі

c.За 1 год після прийому їжі

+ d.За 1-1,5 год до прийому їжі

e.За 3 год після прийому їжі

105.Під час реабілітаційного обстеження чоловіка фізичний терапевт виявив ознаки правостороннього геміпарезу, що є причиною зниження мобільності пацієнта та рівня його побутових навичок. З анамнезу відомо: гостре порушення мозкового кровообігу півроку тому. Яку шкалу застосує фізичний терапевт для кількісної оцінки рухових навичок пацієнта?

a.Комітету медичних досліджень

b.Бартела

+ c.Оцінки моторики Рівермід

d.Для оцінки м'язової сили

e.Модифіковану шкалу спастичності Ашфорта

106.Яке основне завдання фізичної терапії у період загострення хронічного холециститу в пацієнта?

a.Покращення обміну речовин

b.Покращення функції жовчного міхура

c.Зменшення дискінетичних розладів жовчовивідної системи

+ d.Зменшення запального процесу в жовчному міхурі

e.Зменшення температури тіла

107.Пацієнта з дефектом черепа в лівій скронево-тім'яній ділянці на 5 добу після оперативного видалення гематоми вчать переходу з положення лежачи на спині в положення сидючи на краю ліжка. Який спосіб вставання буде пріоритетним для пацієнта в цьому разі?

a.Через неуразену сторону без допомоги фізичного терапевта

+ b.Через уражену сторону з допомогою фізичного терапевта

c.-

d.Через уражену сторону без допомоги фізичного терапевта

e.Через неуразену сторону із допомогою фізичного терапевта

108.Який тренувальний сценарій має формувати фізичний терапевт під час роботи з пацієнтами з наслідками черепно-мозкової травми?

a.Має бути складним для виконання пацієнта

b.Пацієнт має максимально бути залученим до побутової активності

c.Має бути не складним для виконання пацієнту та подобатися йому

d.Має бути спрямованим на вдосконалення навичок володіння кріслом колісним активного типу

+ e.Має відображати ситуації реального життя вдома й на роботі для кожного пацієнта

109.Укажіть найефективнішу стратегію для реабілітації пацієнта, який перехворів на COVID-19 із наявними або тривалими порушеннями функції легень, через 6-8 тижнів після виписки його з лікарні.

a.Курс апаратної фізіотерапії

b.Програма функціональних вправ

+ с.Програма легеневої реабілітації

d.Програма аеробних тренувань

е.Програма фізичної терапії

110.Які клінічні прояви характерні для поздовжньої плоскостопості?

a.Супінація стопи

+ b.Пронація стопи

c.Hallux valgus

d.Аддукція переднього відділу стопи

е.Інверсія стопи

111.Пацієнту після ГПМК треба обстежити ризик падіння. Який тест буде оптимальним для використання, якщо в доступі є коридор довжиною 5 метрів?

a.Тест 20 присідань

b.Динамічний індекс ходьби

c.Тест 6-хвилинної ходьби

+ d.Тест "Встань та йди"

е.Тест Френчай

112.Коли розпочинають післяінсультну реабілітацію із залученнями міждисциплінарної команди за умови стабільного стану пацієнта?

а.Після першого тижня від початку хвороби

б.Після 72 год від початку хвороби

с.Після двох тижнів від початку хвороби

+ д.Після 24-48 год від початку хвороби

е.Після трьох тижнів від початку хвороби

113.Укажіть методичну особливість виконання фізичних вправ на розвиток загальної витривалості.

а.Повторювані вправи низької інтенсивності протягом короткого періоду часу

б.Повторювані вправи високої інтенсивності протягом довгого періоду часу

+ с.Повторювані вправи низької інтенсивності протягом довгого періоду часу

d.Повторювані вправи будь-якої інтенсивності протягом довгого періоду часу

е.Високоінтенсивні вправи протягом короткого періоду часу

114.Який із нижченаведених синдромів вказує на нездатність розпізнавати або оцінювати подразники?

a.Амнезія

b.Афазія

+ c.Агнозія

d.Алексія

е.Апраксія

115.Які завдання необхідно обирати терапевту для оцінки пацієнта, що має нервово-м'язові захворювання, під час розробки подальшого фізіотерапевтичного втручання?

a.Які будуть задовольняти бажання пацієнта та сприяти його задоволенню від реабілітаційного процесу

+ b.Які, ймовірно, будуть викликом для пацієнта, враховуючи підозрілі сфери неефективності, порушень чи проблеми

c.Які будуть відображати фізичний та психоемоційний стани пацієнта, описуючи його когнітивну сферу

d.Спрямовані на визначення основних фізичних якостей пацієнта та його фізичної працездатності

е.Які будуть легкими для виконання пацієнтом та які пацієнт виконує постійно без труднощів, витрат додаткової енергії

116.Під час обстеження стабільності колінного суглоба за тестом Anterior/Posterior Drawer Test (передньої/задньої висувної шухляди) в пацієнта фіксується надмірний рух гомілки вперед більше ніж на 5 мм. Про яку наявну патологію свідчить цей результат?

a.Перелом надколінка

+ b.Передньої хрестоподібної зв'язки

c.Передньої частини меніска

d.Задньої хрестоподібної зв'язки

е.Середньої частини меніска

Під час дослідження чутливості пацієнт сидить із заплющеними очима. Руку пацієнта поперемінно згинають та розгинають у ліктьовому суглобі та просять відповісти на питання, у якому напрямку відбуваються рухи в ліктьовому суглобі. Який вид чутливості оцінюють у цьому разі?

Question 117Answer

a.Стереогнозис

b.Статестезію

c.Дискримінацію

+ d.Кінестезію

е.Локалізацію

118.Під час визначення ефективності програми фізичної терапії оцінюють показники спірометрії. Який показник вказує на зміну легеневої тканини у пацієнтів з пневмонією?

a.МОШ50

b.ЧД

+ c.ЖЄЛ

d.ПШВ

е.ОФВ1

119.Чому відповідає одна метаболічна одиниця?

+ a.Витраті енергії та споживанню кисню, виміряного у спокої, і становить 3,5 л/хв

b.Витраті енергії та споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год, і становить 3,5 мл/кг/хв

c.Витраті енергії та споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год, і становить 3,5 л/кг/хв

d.Витраті енергії та споживанню кисню, виміряного у спокої, і становить 3,5 мл/кг/хв

е.Витраті енергії та споживанню кисню, виміряного під час ходьби зі швидкістю 5 км/год, і становить 3,5 л/хв

120. За рахунок чого відбуваються суттєві поліпшення рівноваги після вестибулярної реабілітації?

- a. Толерантності кардіореспіраторної системи до фізичного навантаження та підвищення загальної фізичної працездатності
- + b. Адаптації ЦНС, сенсорного зміщення або перебалансування систем чуття
- c. Психоемоційної підготовки до виконання фізичної роботи великого обсягу
- d. Тренування нервових волокон периферичних нервів
- e. Зміцнення м'язів і загальних силових показників

121. Синдром неглекту характерний для осіб із гострим порушенням мозкового кровообігу. У якій частці головного мозку локалізована зона ураження?

- a. Мозочка
- b. Скроневій
- c. Потиличній
- + d. Тім'яній
- e. Лобовій

122.Двомісячній дитині встановлено діагноз: вада розвитку ЦНС, мієломенінгоцеле грудного відділу хребта, spina bifida Th8-Th11. Який імовірний прогноз щодо набуття рухових навичок у цьому разі?

a.Сидіти незалежно та перевертатися навчиться вчасно, до 2-3 років навчиться повзати, до 4 років може навчитися ходити в ортезах AFO або KAFO

b.Сидіти незалежно, перевертатися, повзати та ходити навчиться вчасно

+ c.Із затримкою навчиться сидіти за умови підтримки тулуба, можливе опанування перекачування, основний спосіб пересування - крісло колісне

d.Сидіти незалежно, перевертатись і повзати навчиться вчасно, до 2 років навчиться ходити, потребуватиме тренувань на витривалість і зміцнення м'язів, використання ортопедичних устілок

e.Із затримкою навчиться сидіти з опорою на руки, зможе навчитися повзати тільки по-пластунськи, до 5 років може навчитися ходити в ортезах KAFO або HKAFO з використанням ходунків або милиць

123.У жінки віком 68 років діагноз: гостре порушення мозкового кровообігу. Період реабілітації - стаціонарний, 2-й день після перенесеного геморагічного інсульту. Фізичний терапевт, досліджуючи патологічні рефлекси пацієнтки, визначив симптом ураження пірамідальних шляхів за позитивним розгинальним рефлексом у відповідь на стискання литкового м'яза. Який рефлекс досліджував фізичний терапевт?

+ a.Гордона

b.Оппенгейма

с.Шеффера

d.Чадока

е.Бабінського

124.Укажіть протипоказання до призначення заходів фізичної терапії у разі патології печінки та жовчовивідних шляхів.

+ а.Гострий гепатит

b.Постхолецистектомічний синдром

с.Хронічний безкам'яний холецистит

d.Дискінезія жовчовивідних шляхів

е.Хронічний холангіт

125.Яке захворювання характеризується дифузним прогресуючим ураженням бронхіального дерева, зумовлене тривалим подразненням і запаленням повітроносних шляхів різними шкідливими агентами, та проявляється перебудовою секреторного апарату слизової оболонки, розвитком запального процесу та склеротичними змінами в більш глибоких прошарках і супроводжується гіперсекрецією та порушенням очисної функції бронхів?

a.Плеврит

+b.Хронічний бронхіт

с.Бронхіальна астма

d.Гострий бронхіт

е.Пневмонія

126.Що із нижченаведеного використовують для розрахунку, регулювання та контролю інтенсивності тренувань у рамках програми кардіореабілітації?

+ а.Показники ЧСС і споживання кисню, максимальне фізичне навантаження, шкалу Борга

b.Аеробні тренування на витривалість, силові тренування помірної інтенсивності

c.Теренкур, аеробні та силові тренування, дихальні вправи

d.Заняття на велоергометрі або тредмілі, піші прогулянки, скандинавську ходьбу

e.Тривалість, частоту, інтенсивність тренувань, тип вправ

127.Пацієнту віком 63 роки із встановленим діагнозом ішемічної хвороби серця було проведено тредмілєргометрію за стандартизованим протоколом із метою уточнення функціонального класу стабільної стенокардії напруги та оцінки ефективності медикаментозної терапії. Про що свідчить виникнення важкого ангінозного болю як критерію припинення виконання навантажувальної проби?

+ а.Досягнення порогу толерантності до фізичного навантаження

b.Необхідність повторного проведення навантажувальних проб

c.Підвищення тонусу симпатичного відділу нервової системи

d.Підвищення тонусу парасимпатичного відділу нервової системи

e.Необхідність корекції медикаментозної терапії

128.Пацієнтка віком 27 років перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом: гостра лівобічна нижньодольова пневмонія. Укажіть положення тіла, яке необхідно прийняти пацієнтці, під час виконання статичного постурального дренажу.

a.Сидячи, трохи нахилитися вперед і вправо

+ b.Лежачи на правому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30-40 см

c.Лежачи на лівому боці, з валиком під тазом і під нижньою частиною грудної клітки, частина ліжка з боку ніг піднята на 30-40 см

d.Лежачи на правому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см

e.Лежачи на лівому боці, частина ліжка з боку голови піднята на 30 см

129.Під час проведення мануально-м'язового тестування сили м'язів, які розгинають передпліччя, фізичний терапевт встановив, що пацієнт може долати невеликий спротив, при цьому амплітуда руху в ліктьовому суглобі була неповною. Який сегмент спинного мозку, найімовірніше, уражений в цьому разі?

a.C6

+ b.C7

c.C5

d.C3

e.C4

130. Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хв, біль стає нестерпним. Який тип вправ у цьому разі потрібно застосовувати з метою зменшення больових відчуттів?

+ а. На розтягування та зміцнення м'язів передпліччя

b. На збільшення амплітуди

c. З опором

d. На витривалість для згиначів передпліччя

e. Мануальні мобілізаційні техніки

131. За результатами обстеження пацієнта зі спинномозковою травмою виявлено: можливість довільного анального скорочення, збереженість моторної функції нижче неврологічного рівня та силу в половині ключових м'язів 3-4 бали. На який рівень тяжкості спинномозкової травми за шкалою AIS Американської асоціації травм хребта вказують ці результати обстеження?

a. Рівень А - повне ураження

b. Рівень В - неповне сенсорне ураження

c. Рівень С - неповне моторне ураження

d. Рівень Е - сенсорні та моторні функції в нормі

+ e. Рівень D - неповне моторне ураження

132. Під час виписки пацієнта з реабілітаційного неврологічного відділення його результати оцінювання рівноваги за шкалою балансу Берга - 38 балів. Які рекомендації доцільно надати пацієнту щодо безпечного самостійного пересування?

- a. Ходьба без допоміжних засобів пересування та допомоги іншої особи
- b. Ходьба під контролем іншої особи
- + c. Ходьба з опорою на допоміжні засоби або з підтримкою іншої особи
- d. Ходьба без допоміжних засобів лише рівною поверхнею
- e. Переміщення на візку

133. Що оцінюється за допомогою мануально-м'язового тестування?

- a. Пропріоцепція
- b. Витривалість м'язів
- c. Чутливість м'язів
- d. Діапазон рухів у суглобах
- + e. Сила м'язів

134. У пацієнта із травмою спинного мозку після вогнепального поранення проведено обстеження за шкалою ASIA. За результатами мануально-м'язового тестування половина провідних м'язів має оцінку 3 і більше балів нижче неврологічного рівня травми та крижове збереження. Який рівень за шкалою ASIA буде присвоєне цьому пацієнтові?

+ a.D

b.A

c.E

d.B

e.C

135. До якої групи належать симптоми Ласега, Нері, Вассермана?

a.Менінгеальні

b.Стопні патологічні

+ c.Натягу периферичних нервів і нервових корінців

d.Орального автоматизму

e.Випадіння

136. Яку мету відповідно до принципу SMART можна вважати короткотривалою для пацієнта зі спинномозковою травмою в гострому реабілітаційному періоді?

a. Регулярна участь у громадських заходах

+ b. Опанування техніки переміщення з ліжка на візок і навпаки

c. Досягнення повної незалежності в догляді за сечовим міхуром і кишечником

d. Самостійна купівля пляшки води

e. Участь у місцевому адаптивному спортивному заході

137. Пацієнт віком 62 роки перебуває на реабілітації у зв'язку з перенесеним ішемічним інсультом. Фізичний терапевт проводить втручання для корекції тіла пацієнта, оскільки наявний синдром "відштовхування" (push-синдром). Яка мета такого втручання?

a. Дотягнутися паретичною ногою до здорової руки

b. Дотягнутися паретичною рукою та паретичною ногою до здорового боку

c. Дотягнутися паретичною рукою до здорової ноги

+ d. Дотягнутися здоровою рукою та здоровою ногою до здорового боку

e. Дотягнутися здоровою рукою та здоровою ногою до ураженого боку

138. Під час обстеження чотиримісячної дитини щодо підвищеного тону м'язів фізичним терапевтом використано тест для оцінки ризику розвитку церебрального

паралічу, що включає неврологічне обстеження, оцінку розвитку моторних функцій та поведінку. Який тест використав фізичний терапевт у цьому разі?

- a.Ашворта
- b.GMFCS
- c.PEDI
- d.AIMS
- + e.HINE

139.У пацієнта 4 дні тому розвинувся ішемічний інсульт із вираженою дисфагією, лівобічний геміпарез. Яке положення пацієнта під час позиціонування в ліжку провокує аспіраційну пневмонію?

- +a.Лежачи на спині
- b.Лежачи на правому боці
- c.Лежачи на лівому боці
- d.Сидячи з опущеними вниз ногами
- e.Положення Фаулера

140.Під час планового огляду тримісячного хлопчика неврологом виявлено значно підвищений тонус м'язів-розгиначів і привідних м'язів обох ніг, а також надмірний тонус черевних м'язів. Про яку форму ДЦП можуть свідчити такі клінічні ознаки?

- a.Спастичну геміплегію

b.Гіперкінетичну

c.Дискінетичну

d.Атонічно-астатичну форму Ферстера

e.Спастичну диплегію

141.Жінці віком 69 років діагностовано пневмонію середнього ступеня тяжкості з ураженням задніх основних сегментів обох легень. Аускультативно вислуховуються вологі хрипи. Яку дренажну позицію доцільно застосувати пацієнтці для поліпшення відходження мокротиння?

a.Положення сидячи в нахилі з опорою ліктями на коліна

+ b.Положення на животі, верхня частина тулуба опущена відносно горизонтальної площини

c.Положення лежачи на спині, верхня частина тулуба опущена відносно горизонтальної площини

d.-

e.Положення на правому боці з напівобертом на спину

142.У дитини з ДЦП спостерігаються такі симптоми: несвідомі, неконтрольовані, повторювані, іноді стереотипні рухи уражених частин тіла. Дитина має труднощі з сидінням і ходьбою. Укажіть форму ДЦП.

a.Спастична диплегія

b.Спастичний геміпарез

с.Спастичний тетрапарез

+ d.Дискінетична форма

е.Атаксія

143.У чому полягає одна з ролей фізичного терапевта в нейрореабілітації військовослужбовців із легкою ЧМТ?

a.Надання психоемоційної підтримки та психологічного супроводу

b.Пояснення щодо особливостей тренування загальної фізичної підготовки та інтеграція в спорт вищих досягнень

с.Пояснення важливості силових тренувань через біль і втому для вдосконалення фізичних функцій

d.Пояснення щодо медикаментів і важливості медикаментозної підтримки

+ e.Пояснення щодо адаптації нервової системи та її потреби в дозованому навантаженні для полегшення процесу одужання

144.Жінці віком 59 років встановлено діагноз: остеоартрит правого колінного суглоба в стадії загострення. Які спеціальні вправи для ураженої нижньої кінцівки порекомендує фізичний терапевт пацієнтці для виконання у домашніх умовах?

a.Статичні з осьовим навантаженням

+ b.Ізометричні без осьового навантаження

- с.Активні на збільшення амплітуди руху
- d.Ексцентричні з осьовим навантаженням
- е.Пасивні на збільшення амплітуди руху

145.Для якої патології ефекторно-вольової сфери характерні такі симптоми: повна відсутність активних рухів кінцівки або кінцівок, збільшення м'язового тону, гіперрефлексія, синкінезія, позитивні патологічні рефлекси, збережена трофіка м'язів?

- a.Палеоцеребрального синдрому
- + b.Центрального мотонейрона
- с.Неоцеребрального синдрому
- d.Хореатичного синдрому
- е.Периферійного мотонейрона

146.Під час тестування фізичним терапевтом чоловіка віком 80 років виявлено, що пацієнту складно сконцентруватися та зрозуміти поточну ситуацію, є проблеми з пам'яттю та іншими когнітивними здібностями. Для якого захворювання характерні такі клінічні показники?

- a.Деадаптації
- b.Хвороби Паркінсона
- + c.Деменції

d.Гострого порушення мозкового кровообігу

е.Депривації

147.Чим викликаний ціаноз шкірних покривів у кардіологічних пацієнтів?

a.Звуженням вен, звуженням капілярів, застоєм

+ b.Розширенням вен, розширенням капілярів, застоєм

c.Звуженням вен, розширенням капілярів, застоєм

d.Звуженням вен, звуженням капілярів, крововідтоком

е.Розширенням вен, звуженням капілярів, застоєм

148.У спортсмена спостерігається пошкодження м'язів, спричинене фізичним навантаженням (EIMD). Який метод доцільно застосувати в практичній діяльності, заснований на доказах?

a.Тейпування

b.Електрофорез

+ c.Кріотерапію

d.Постізометричну релаксацію

е.Термотерапію

149.Які клінічні прояви клишоногості?

+ а.Еквінус у гомілково-надп'ятковому суглобі та аддукція стопи

б.Супінація стопи та абдукція стопи

с.Пронація стопи та аддукція стопи

д.Збільшення дорсіфлексії стопи

е.Абдукція стопи та пронація стопи

150.З якою метою виконуються пасивні вправи на розтяг м'язів у пацієнтів зі спастичністю, що викликана травмою чи захворюванням центральної нервової системи?

+ а.Для профілактики контрактур

б.Для формування рухових навичок

с.Для венозного відтоку в спазмованих м'язах

d.Для тренування сили м'язів

е.Для зменшення спастичності та тону́су м'язів